# TUMORES DE ESÓFAGO

DR. PABLO DURAN

## CARCINOMA ESCAMOSO

- Predomina a nivel mundial; puede aparecer en cualquier segmento (cervical o torácico).
- Factores: tabaco y alcohol (sinergia), acalasia, cáusticos, cáncer de cabeza y cuello previo.
- Otros: vegetales fermentados, radiación, asbesto, anemia de Fanconi y tilosis.

## ADENOCARCINOMA

- Predomina en el esófago distal/unión gastroesofágica en Occidente.
- Secuencia: ERGE crónico + obesidad central → Barrett → metaplasia intestinal → displasia → adenocarcinoma.
- La mayoría con Barrett nunca desarrollará cáncer.

## CLÍNICA

- Disfagia progresiva (sólidos → semisólidos → líquidos): síntoma clásico pero alarma tardía.
- Pérdida de peso, odinofagia, dolor retroesternal, anemia o sangrado oculto, hematemesis.
- Tos, aspiración o ronquera sugieren extensión local.

## CUÁNDO SOSPECHARLO

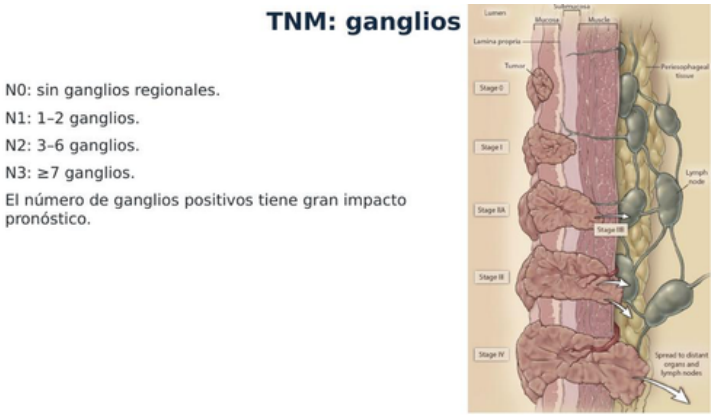
- Disfagia nueva o progresiva, pérdida de peso no explicada o anemia ferropénica con síntomas digestivos altos.
- No retrasar la endoscopia con pruebas empíricas prolongadas.







## ESTADIFICACIÓN TNM




## CÁNCER MUY TEMPRANO (Tis/T1a)

- Resección endoscópica (mucosectomía o disección submucosa) ± ablación del Barrett residual.
- La displasia severa en endoscopia es cáncer temprano.

## CÁNCER T1b

- Mayor riesgo ganglionar: cirugía preferida en el paciente operable.

## LOCALMENTE AVANZADO RESECABLE

- cT2–4a o N+: quimiorradiación neoadyuvante + esofagectomía (CROSS) o quimioterapia perioperatoria (FLOT) en adenocarcinoma/unión gastroesofágica.

## ENFERMEDAD METASTÁSICA

- T4b o M1: no es escenario de esofagectomía curativa estándar.
- Objetivos: prolongar supervivencia, controlar síntomas y mantener deglución/nutrición; sistémico según histología y biomarcadores; cuidados paliativos tempranos.

## PALIACIÓN DE LA DISFAGIA

- Stent metálico autoexpandible: alivio rápido.
- Radioterapia/braquiterapia: alivio gradual, potencialmente más duradero.
- Dilatación: utilidad limitada y riesgo de perforación.

# TUMORES DE ESÓFAGO

DR. PABLO DURAN

**ANATOMÍA QUIRÚRGICA**

- Esófago cervical, torácico superior, medio e inferior.
- Sin serosa: facilita la extensión local; drenaje linfático longitudinal y bidireccional.
- Relaciones: tráquea/bronquios, aorta, pericardio, pleura y nervios recurrentes laríngeos.

**LA BIOPSIA MANDA**

- Endoscopia alta para localizar, describir y tomar múltiples biopsias.
- La patología define histología y grado; en adenocarcinoma avanzado, biomarcadores.

**REPORTE ENDOSCÓPICO**

- Distancia desde incisivos y longitud; % de circunferencia y estenosis; relación con la unión gastroesofágica; Barrett u otras lesiones; si el endoscopio atraviesa la lesión.

**CUATRO PREGUNTAS DE ESTADIFICACIÓN**

- ¿Qué tan profundo invade? (T) ¿Hay ganglios? (N) ¿Hay metástasis? (M) ¿Es resecable y el paciente operable?

**ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO (EUS)**

- Mejor para T y ganglios locales: diferencia las capas y permite FNA/FNB.
- Limitación: estenosis que impide el paso; no sustituye al PET/CT.

**TC Y PET/CT**

- TC tórax/abdomen: anatomía, invasión y metástasis.
- PET/CT: detecta metástasis ocultas; un PET negativo no excluye micrometástasis.

**TNM**




**RESECCIÓN ENDOSCÓPICA**

- EMR/ESD trata y estadifica: mide la profundidad real, los márgenes y la invasión linfovascular.
- Puede evitar la esofagectomía en enfermedad mucosa de bajo riesgo.

**ESQUEMA CROSS**

- Quimiorradiación neoadyuvante (carboplatino + paclitaxel con radioterapia) seguida de esofagectomía.
- Mejora el control local frente a cirugía sola; especialmente relevante en escamoso.
- En adenocarcinoma de esófago ya no se usa radiación en neoadyuvancia.

**QUIMIOTERAPIA PERIOPERATORIA (FLOT)**

- Establecida en adenocarcinoma resecable de estómago/unión gastroesofágica; trata micrometástasis temprano; requiere paciente apto.

**RESTADIFICACIÓN**

- Tras neoadyuvancia: reevaluar metástasis, resecabilidad y estado nutricional y funcional; evitar cirugía si aparece metástasis inequívoca.

**PRINCIPIOS DE LA ESOFAGECTOMÍA**

- Resección R0, linfadenectomía adecuada y reconstrucción con tubo gástrico; mejores resultados en centros de alto volumen.

**IVOR LEWIS**

- Abdomen + tórax; anastomosis intratorácica.

**McKEOWN**

- Abdomen + tórax + cuello; anastomosis cervical.

**TRANSHIATAL**

- Abdomen + cuello, sin toracotomía formal.

**ELECCIÓN DEL ABORDAJE**

- Localización, margen proximal, patrón ganglionar, cirugías previas, condición cardiopulmonar y experiencia del equipo.

**CONDUCTO GÁSTRICO**

- Preferido: preservar la gastroepiploica derecha y evitar tensión y torsión; colon o yeyuno como alternativas.

**COMPLICACIONES DE LA ESOFAGECTOMÍA**

- Fuga anastomótica, complicaciones pulmonares, arritmias (fibrilación auricular), lesión del recurrente laríngeo, quilotórax, estenosis anastomótica y vaciamiento gástrico tardío.

# TUMORES DE ESÓFAGO

DR. PABLO DURAN

**FUGA ANASTOMÓTICA**

- Sospechar ante taquicardia, fiebre, sepsis, dolor o deterioro respiratorio.
- TC con contraste y endoscopia según escenario.
- Drenaje, antibióticos y soporte; endoscopia o cirugía en casos seleccionados.

**NUTRICIÓN**

- Pérdida de peso y sarcopenia frecuentes: evaluar desde el diagnóstico y preferir la vía enteral.
- Evitar procedimientos que comprometan el futuro conducto gástrico sin discutirlo con cirugía.

**ESCAMOSO CERVICAL O NO OPERABLE**

- Quimiorradiación definitiva puede ser curativa; cirugía de rescate solo en seleccionados.
- La respuesta clínica completa no siempre es respuesta patológica completa.

**NIVOLUMAB ADYUVANTE**

- Tras quimiorradiación neoadyuvante + resección R0 con enfermedad residual: estándar aprobado, hasta 1 año (CheckMate 577); no aplica igual con respuesta patológica completa.

**BIOMARCADORES EN ADENOCARCINOMA**

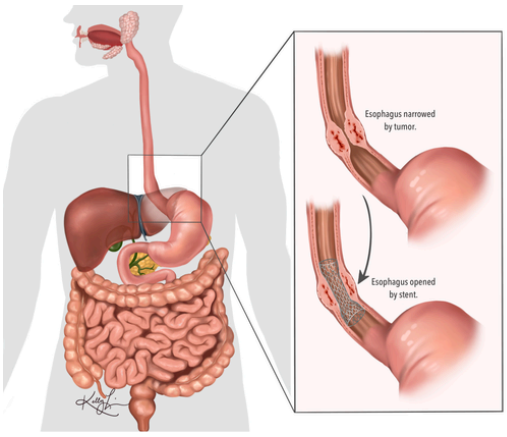
- HER2, PD-L1 (CPS), MSI/MMR y, según disponibilidad, CLDN18.2; solicitarlos temprano si cambian la primera línea.

**INMUNOTERAPIA EN ENFERMEDAD AVANZADA**

- Inhibidores PD-1 en múltiples esquemas de primera línea; selección según histología, biomarcadores y aprobación local.

**¿STENT ANTES DE CIRUGÍA CURATIVA?**

- No es rutinario: puede complicar el manejo y no siempre es la mejor estrategia nutricional.
- Prioridad: completar estadificación y discutir en equipo multidisciplinario.




**PRONÓSTICO**

- Estadio TNM, respuesta a la neoadyuvancia, resección R0, número de ganglios positivos y estado funcional, nutricional y comorbilidades.

**SEGUIMIENTO**

- Historia y examen dirigidos a síntomas; imágenes/endoscopia según protocolo.
- Manejar nutrición, reflujo, estenosis y función pulmonar; priorizar calidad de vida.

**ERRORES FRECUENTES**

- Operar antes de completar la estadificación; confundir T1a con T1b; usar PET en lugar de EUS para T local.
- Olvidar nutrición y evaluación cardiopulmonar; no discutir en comité; asumir que respuesta clínica completa = sin tumor.